

浙江省中医门、急诊病历评分标准

(定稿)

科室： 经治医师： 病人姓名： 门诊号： 得分：

项目	检查内容	评分说明	扣分及理由
基本要求 (5分)	1.病历书写应规范使用医学术语，中医术语的使用依照相关标准、规范执行。 2.门(急)诊病历记录应当由接诊医师在患者就诊时及时完成。 3.病历要求表述准确，语句通顺，标点正确。病历书写一律使用阿拉伯数字书写日期和时间，采用24小时制记录。	1.医学术语不规范扣1分/处。 2.日期和时间不规范扣1分/处。 3.未按时完成扣5分。	
患者基础信息 (10分)	1.病历首页应包括患者姓名、性别、出生年月日、民族、婚姻状况、职业、工作单位、住址、药物过敏史等。 2.每次就诊应有就诊科室及时间。 (患者基础信息在门诊病历或门诊电子病历系统可以查到的即可作为检查依据)。	1.基础信息缺项扣1分/项。其中缺食物、药物过敏史扣5分。 2.无就诊时间及科室扣2分。	
主诉 (5分)	1.应记录初诊病人要记录病人就诊的主要症状、体征及持续时间。 2.明确诊断的复诊、随访可用诊断代替症状体征。	1.主要症状、体征记录不规范扣2分。 2.持续时间未记录扣2分。	
现病史 (20分)	1.应记录本次起病的主要症状、体征。 2.应记录患者发病来主要的诊治经过及结果。 3.复诊病人应记录治疗后症状改变情况。	1.主要症状、体征描述不清扣5分。 2.缺诊治经过扣2分。 3.复诊无症状改变记录扣5分。	
既往史 (10分)	初诊应记录患者重要的既往病史、传染病史、手术史、月经史、生育史、家族史、长期用药史等。	育龄期妇女无月经史扣5分。	
体格检查 (10分)	1.按照中医四诊要求记录重要的阳性体征及必要的阴性体征舌脉象，能支持疾病诊断。 2.复诊病人也应有。	1.缺中医四诊扣10分。 2.舌脉象不支持诊断扣5分。 3.复诊病人缺必要的体格检查扣5分。	
辅助检查及结果 (5分)	应记录重要的辅助检查结果。	未记录扣5分。	
诊断 (10分)	1.规范书写中、西医诊断。 2.中医诊断包括疾病诊断与证候诊断。	有中医治疗的病历无中医诊断扣10分，中医诊断不全扣2分。	

治疗意见及措施 (10分)	1.检查治疗项目明确、规范。 2.药品使用规范，超说明书用药应说明情况。 3.实施中医治疗的应当遵循辨证论治的原则。 4.有复诊建议及注意事项。	1.检查治疗项目不明确扣5分。 2.治则治法与证型不符扣5分。 3.无复诊建议或注意事项扣5分。	
知情同意书 (5分)	1.对需取得患者书面同意方可进行的医疗活动，应当由患者本人签署知情同意书。患者不具备完全民事行为能力时，应当由其法定代理人签字；患者因病无法签字时，应当由其授权的人员签字。为抢救患者，在法定代理人或被授权人无法及时签字的情况下，可由医疗机构负责人或者授权的负责人签字。 2.因实施保护性医疗措施不宜向患者说明情况的，应当将有关情况告知患者近亲属，由患者近亲属签署知情同意书，并及时记录。患者无近亲属的或者患者近亲属无法签署同意书的，由患者的法定代理人或者关系人签署同意书。	需知情告知的未与执行扣5分。	
其他 (10分)	1.急诊病历书写就诊时间应当具体到分钟。 2.急诊病人无T、P、R、BP生命体征记录。 3.急诊留观记录重点记录观察期间病情变化和诊疗措施，记录简明扼要，并注明患者去向。 4.实施中医治疗的，应记录中医四诊、辨证施治情况等。 5.抢救危重患者时，应当书写抢救记录（参照住院病历抢救记录书写内容及要求）。	1.未具体到分钟扣5分，无T、P、R、BP生命体征记录扣2分。 2.留观记录不规范扣5分。 3.患者去向未记录扣2分。 4.实施中医治疗无中医四诊等内容扣5分。 5.抢救记录未记录扣10分，不规范扣5分。	

注：1.本标准依据《中医病历书写基本规范》制定。

2.病历质控检查建议重点抽查首诊病历、门诊疑难病历。

3.扣分标准未注明具体扣分要求的可根据病历记录情况酌情扣分。

4.手写病历要求文字工整、字迹清晰，书写过程中出现错字应当用双线划在错字上，保留原记录清楚、可辨，并注明修改人签名和修改时间。不得采用刮、粘、涂等方法掩盖或去除原来的字迹。

5. 90分以下判定为不合格病历。

检查者：

检查日期：